

요약

- 국토교통부는 범부처 합동으로 「자동차보험 부정수급 개선 대책」을 발표하고 관련 시행령, 시행규칙 개정안을 입법 예고함
 - 경상환자 1인당 치료비와 향후치료비는 2018년부터 5년 동안 1.6배, 1.3배 증가함
 - 일부 경상환자의 장기 치료를 억제하기 위해 치료기간 8주 초과 시 공적기구의 치료 필요성 확인 절차를 마련함
- 장기 치료 여부에 대한 공적기구의 판단은 2023년 「경상환자 대책」을 강화한 것임
 - 「경상환자 대책」의 핵심은 4주 초과 치료 시 2주 단위 진단서 의무 제출인데, 무분별한 진단서 제출이 만연하면서 제도의 효과성이 낮아짐
 - 「경상환자 대책」 시행으로 2023년 경상환자 치료비와 향후치료비 증가세는 둔화되었지만 2024년에는 다시 증가세로 전환됨
 - 「자동차보험 부정수급 개선 대책」은 무분별한 진단서 발급을 관리하고 사고발생 8주차에 간접적인 상해평가를 통해 치료의 실효성을 높이려는 방안임
- 경상환자 상해의 불확실성으로 인해 발생하는 장기 치료와 보험금 증가로 인한 사회적 비용을 관리하기 위해서는 향후치료비 지급기준 마련 등 경상환자 보상제도의 합리성 제고가 필요함
 - 경상환자에게 합의금 역할을 하는 향후치료비는 “합의금을 위한 치료”를 유도하는데, 경상환자에 대한 보험금 증가, 선량한 계약자의 보험료 인상 압력으로 작용함
 - 캐나다, 미국, 프랑스, 일본 등은 경상환자에 대한 합의금, 치료기간 및 방법을 관리하고 있음
 - 경상환자 입원 기준 검토, 향후치료비의 취지에 부합하는 지급기준 마련, 휴업손해, 위자료 등 보상 기준의 합리화와 보상의 투명성 제고 방안을 모색해야 함

1. 검토 배경

- 국토교통부는 범부처 합동으로 2025년 2월 26일 「자동차보험 부정수급 개선 대책」을 발표하고 관련 시행령, 시행규칙 개정안을 2025년 6월 20일 입법예고하였고 7월 30일까지 의견을 수렴함¹⁾
 - 국토교통부, 금융위원회, 금융감독원은 경상환자의 보상목적의 치료 억제를 위해 향후치료비 지급기준을 마련하고 8주 초과 치료가 필요한 환자는 공적기구에 진료기록, 검사기록을 제출·심의를 받도록 함
 - 기존 「경상환자 대책」에 8주 초과 치료 시 공적기구 심의결과에 따른다는 점이 추가된 것으로 2회 이상 진단서를 제출할 필요가 없음
 - 치료비가 책임보험금 한도금액을 초과할 경우 적용되는 과실책임주의는 계속 적용됨
- 제도개선의 배경은 다양한 대책에도 불구하고 치료비와 향후치료비 증가세가 지속되고 건강보험 치료비에도 부정적 영향을 미치기 때문으로 보임
 - 2012년 8월 허위·부재 환자를 줄이기 위해 상해급수 11급 뇌진탕, 12~14급의 경상환자에 대해 통원치료를 원칙으로 하는 「자동차사고 환자 입원기준」을, 2023년 1월에는 「경상환자 대책」을 시행하였음
 - 그럼에도 치료비와 향후치료비는 우리나라 국내총생산보다 빠르게 증가하였는데, 2023년 4/4분기 1인당 경상환자 치료비는 128.3만 원, 1인당 향후치료비는 106.0만 원으로 5년 전인 2018년 1/4분기에 비해 각각 1.6배, 1.3배 증가함
 - 명목국내총생산은 2023년 4/4분기 635.7조 원으로 2018년 1/4분기 대비 1.3배 증가함
 - 우리나라는 건강보험 건전성 유지를 위해 자동차보험 치료를 건강보험 치료와 분리하는데, 감사원에 따르면 자동차보험 합의한 후 6개월 이내에 동일 상병으로 건강보험에서 치료받은 환자는 전체 경상환자의 10.6%로 나타남²⁾
- 본고에서는 2025년 발표된 「자동차보험 부정수급 개선 대책」을 시행령과 시행규칙 개정안을 중심으로 2023년 「경상환자 대책」 및 주요국 제도개선 사례와 비교하고 기대효과를 검토함³⁾

2. 「경상환자 대책」과의 비교

- 2023년 1월부터 시행된 「경상환자 대책」은 사고 발생 4주가 지난 치료 시 진단서 제출을 의무화하고 치료비가 책임보험금 한도금액을 초과할 경우 과실책임주의를 도입한 조치임
 - 경상환자의 기준 치료기간을 4주로 규정하였고 4주 초과 치료에 대해 2주 단위로 진단서를 제출함
 - 과실책임주의는 경상환자의 치료비가 책임보험 한도금액(상해급수 12급 120만 원, 14급 50만 원)을 초과할 경우

1) 금융위원회 관계부처합동 보도자료(2025. 2. 26.), “자동차보험, 합리적 보상 보험료 개선...국민 부담 낮춘다”

2) 2019년부터 2022년 동안의 평균임; 감사원(2025. 4.), 「건강, 실손, 자동차보험 등 보험서비스 이용실태」

3) 금융감독원 보도자료(2022. 12. 27.), “자동차보험 표준약관, ‘23.1.1.부터 이렇게 바뀝니다”

초과한 금액에 대해 과실비율을 적용하는 것임

○ 제도가 시행된 2023년에는 치료비 증가가 정체되고 향후치료비가 감소하였으나 2024년 다시 치료비가 증가하고 향후치료비 감소폭이 줄어들어 제도개선 효과가 줄어든 것으로 나타남

- 2023년 4개 국내 대형손해보험회사의 자동차보험 치료비는 2022년과 유사한 1.77조 원 수준이었으나 2024년 한방치료비를 중심으로 1.83조 원으로 3.0% 증가함

〈표 1〉 주요 대형 손해보험회사의 자동차보험 경상환자 치료비

(단위: 십억 원, %)

구분	2020	2021	2022	2023	2024
치료비	1,656.5	1,725.8 (4.2)	1,773.3 (2.8)	1,773.6 (0.02)	1,826.3 (3.0)
한방 치료비	728.4	872.0 (19.7)	975.7 (11.9)	1,005.6 (3.1)	1,103.2 (9.7)
의과 치료비	797.4	698.6 (-12.4)	643.0 (-8.0)	635.4 (-1.2)	567.9 (-10.6)
병실료	130.7	155.2 (18.7)	154.6 (-0.4)	132.6 (-14.2)	155.2 (17.0)
향후치료비	1,170.2	1,216.1 (3.9)	1,319.4 (8.5)	1,266.7 (-4.0)	1,261.3 (-0.4)

주: 1) 자동차보험 시장점유율 상위 4개사 대상으로 집계된 자료이며 괄호 안은 전년 대비 증가율임

2) 한방진료비는 모든 종별 의료기관에서 처치하는 한방진료비의 합계임

자료: 손해보험협회

○ 「경상환자 대책」 효과가 감소한 직접적인 원인은 진단서 발급 남용, 한방치료비와 병실료 증가이고 제도적 원인은 지급보증제도임

- 자동차손해배상보장법의 지급보증 관련 규정(제12조)은 자동차보험 환자의 치료비 금액이나 기한 한정없는 치료를 보장하는데, 진단서가 발급되면 경상환자는 무한정 치료를 받을 수 있음
- 한방치료비는 2022년 9,757억 원에서 2023년 1.0조 원으로 3.1% 증가하였고 2024년에는 1조 1,032억 원으로 9.7% 증가함(표 1) 참조)
- 경상환자의 입원으로 인한 병실료는 2023년 1,326억 원으로 전년 대비 14.2% 감소하였으나 2024년에는 1,552억 원으로 17.1% 증가함(표 1) 참조)
- 진단서 발급 비용이 급증하여 발급이 남용되는 것으로 추정되며 2024년 치료일수와 치료비가 증가함
 - 2023년 국내 대형 손해보험회사 2곳의 진단서 발급비용은 10억 6,276만 원으로 2022년 1억 621만 원에 비해 10배 이상 증가함⁴⁾

4) 매일경제(2024. 8. 5.), “누수 막으려 차보험 고쳤지만 효과없이 진단서 비용 10배로”

- 2024년 1곳에서 치료받은 환자 비중이 상승하고 통원일수는 늘어난 것으로 나타나 합의기간은 소폭 늘어난 것으로 보인 반면 2곳 이상의 의료기관에서 치료받은 환자 비중은 감소함
- 치료받은 의료기관 수에 따라 평균 치료비는 높아지고 2024년 치료비는 모든 의료기관에서 2023년 대비 높아진 것으로 나타남
- 2024년 2곳 이하의 의료기관에서 치료받은 경상환자의 통원일수는 2023년에 비해 늘어난 것으로 나타났음

〈표 2〉 진료받은 의료기관 수에 따른 경상환자의 진료행태

(단위: %, 일, 만 원)

의료기관 수	1곳			2곳			3곳			4곳 이상		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
환자 비중	35.2	35.4	36.2	35.0	35.5	34.7	19.0	19.0	18.5	10.9	10.2	10.5
평균 통원일수	5.2	4.9	5.3	8.4	8.1	8.4	12.0	12.0	12.0	21.0	20.0	19.0
평균 입원일수	0.4	0.4	0.3	2.4	2.0	2.2	5.1	4.5	3.8	8.1	6.3	6.1
입원환자 비중	7.4	8.1	7.3	21.0	21.0	24.0	24.0	26.0	25.0	23.0	23.0	24.0
평균 치료비	43.0	45.3	49.5	109.0	107.0	121.0	185.9	189.1	189.2	294.4	275.5	289.5

자료: 2022년부터 2024년 국내 대형손해보험회사 자동차보험 진료비명세서 30,391건을 분석한 결과임

- 국토교통부가 발표한 「자동차보험 부정수급 개선 대책」의 취지는 기존 「경상환자 대책」의 한계를 보완하여 장기 치료의 효과성을 제고하는 것임
 - 손해는 통상의 손해와 특별 손해로 구분할 수 있는데, 통상의 손해를 배상하는 것이 통상의 치료기간, 특별 손해에 대한 배상은 8주를 초과하는 치료로 볼 수 있음
 - 국토교통부에 따르면 경상환자 90%가 치료를 8주 이내에 종료하고 10%만이 8주 이상 치료를 받음
 - 경상환자의 불필요한 과잉진료 억제를 위해 통상의 치료기간을 8주로 규정하고 장기치료를 희망할 경우 공적 기구에 심의를 요청, 심의 결과에 따라 추가 치료 여부가 결정됨

3. 주요국 경상환자 제도와 비교

- 미국, 일본, 캐나다 등 주요국에서도 자동차보험, 근재보험 등 배상책임보험에서 경상환자는 도덕적 해이 유인이 크고 위자료(합의금) 목적의 치료비 증가를 초래하는 것으로 분석됨⁵⁾
 - 경상환자는 중상해 환자와는 다르게 상해 발생 및 회복 여부를 객관적으로 입증하기 어려워 치료비와 위자료 등 보험금을 더 받을 수 있음
 - 염좌, 뱀 등의 편타성 상해(Whiplash)는 입증하기 어렵기 때문에 일부 환자들은 장기 치료의 유인에 노출됨

5) 전용식(2022), 『자동차보험 경상환자 과잉진료비 분석 및 규모 추정 연구』, 이슈보고서, 보험연구원; 전용식·이태열(2024), 『자동차보험과 건강보험 진료수가 차이와 사회적 비용: 자기신체사고 사례』, 연구보고서, 보험연구원에서 재인용함

- 선행연구에서 합의금이 치료비를 높이는 원인으로 작용하는 것으로 나타남
 - 치료비가 일정 수준(2,000달러)을 초과할 경우 합의금을 보상하는 미국 매사추세츠의 노-폴트 제도가 해당 지역의 자동차보험 환자들의 과잉진료 원인인 것으로 분석됨
 - 배상책임제도 지역에서는 대인배상 합의금이 치료비의 2~3배로 책정되는 관행으로 교통사고 환자들은 허위로 치료비를 청구하거나 치료비를 부풀리는 유인이 있었음

○ 과잉치료 유인 억제를 위해 위자료(합의금) 제도를 개정하거나 경상환자의 치료기간, 치료비 상한을 설정한 국가도 있고 경상환자의 상해 입증 요건을 강화하여 경상환자의 과잉치료를 억제하고 있음

- 미국에서는 1980년대 위자료 상한을 설정하는 배상책임개혁이 자동차보험 대인배상 보험금 규모와 소송 건수를 감소시킨 것으로 분석됨
- 영국은 편타성 상해 등 경미상해 환자에 대한 위자료 상한을 설정함
- 캐나다 온타리오주는 2014년부터 경상환자의 치료기간과 치료비 상한을 설정하였고 캐나다 브리티시 콜롬비아는 처치 횟수와 비용을 제한함
 - 캐나다 앨버타는 교통사고 이후 3개월 이내 상해 평가를 해야 하며 보험회사는 상해 평가 비용과 10~21개 처치에 소요된 의료비를 보상함
- 스페인과 이탈리아는 경상환자에 대한 위자료 보상 기준을 엄격하게 하고 있는데, 치료비는 건강보험에서 보장하고 비경제적 손해(위자료)는 상해를 입증하는 경우에만 보상함
- 일본, 프랑스, 네덜란드는 증상의 고정 시점을 적용하여 경상환자의 치료기간을 제한하고 있음
 - 일본, 프랑스와 네덜란드는 상해평가를 통해 보험금을 결정하고 피해자의 상해가 더 이상 회복되지 않는 증상의 고정(Stabilized Medical Condition) 시점에서 피해자와 가해자가 합의할 수 있는데, 네덜란드와 일본에서는 증상고정 시점 이전이라도 합의할 수 있음

○ 국토교통부가 발표한 대책은 환자의 치료를 주요국에 비해 자유롭게 보장하고 의료기관의 치료방법도 제한하지 않는 방안임

- 경상환자의 상해 평가를 사고 발생 시점이 아닌 사고 발생 이후 8주로 규정하고 치료비, 치료 방법에 대한 제한이 없음
- 8주 초과 치료 여부는 중립적인 공적기구의 공정한 의학적 심사를 통해 결정함

4. 쟁점, 기대효과와 후속과제

○ 이번 국토교통부 대책에서 논란이 될 수 있는 점은 경상환자의 통상의 치료기간 8주와 보험회사의 심사 여부임

- 경상환자에 대한 통상의 치료기간은 우리나라의 다른 보험, 그리고 주요국에서 정하고 있고 공적기관 심의 이후 치료를 더 받을 수 있어 치료를 제한하는 방안이라 보기 어려움
 - 자동차보험 경상환자의 상해에 대해 대한의사협회의 진단서 등 작성 교부지침에서는 치료 종결기간을 4주로 보고 있으며, 우리나라 산재보험에서는 6주, 캐나다 온타리오 12주, 일본은 의사와 가 피해자의 협의를 통해 치료 종결 시점을 규정함
- 자동차보험 환자 치료비 심사는 건강보험심사평가원에 위탁되어 보험회사는 심사와는 무관한데, 쟁점이 되는 이유는 보험회사에 대한 낮은 신뢰도 때문일 수 있음

○ 경상환자 치료기간 8주는 사회적으로 인정되는 피해자의 기본 치료(통상의 손해)로 볼 수 있고 이를 초과하는 피해자 개별적 요인에 따른 추가 치료(특별손해)는 공적기구 심의를 통해 결정하는데 특별손해 규모는 크지 않을 것으로 보임

- 경미한 사고에서 발생한 상해의 존재 여부와 심도의 불확실성이 크기 때문에 경험적인 통상적인 치료기간에 근거하여 8주를 산출함
- 공적기구 심의에서 치료의 필요성이 인정되는 경우는 크지 않을 것으로 보임
 - 자동차보험 합의 후 국민건강보험으로 치료받은 환자의 자동차보험 경상환자 대비 비중이 10% 내외임
 - 2006년부터 2016년까지 10년 동안 자동차보험 합의 후 건강보험으로 진료받은 환자들의 통원일수는 3.9일, 평균 치료비는 30.6만 원(공단부담금 22.8만 원, 본인부담금 7.8만 원)⁶⁾임

○ 경상환자 치료기간에 대한 제도개선이기 때문에 입원비율 상승을 통한 치료비 증가로 이어질 수 있어 후속과제로 경상환자 입원기준에 대한 검토가 필요함

- 2023년 경상환자 대책에도 불구하고 경상환자 입원비율이 2022년 26.4%에서 2024년 28.8%로 한방병원을 중심으로 상승하고 있어 경상환자 입원기준 마련도 검토될 필요가 있음⁷⁾
 - 자동차보험진료수가 기준에서 정의한 “일반병실 부재”로 인한 부득이한 경우, 한방병원이나 한의원이 3인실 이상 병실만 보유하는 경우 경상환자가 7일까지 입원할 수 있는 허점을 갖고 있음

○ 그리고 향후치료비 지급기준이 마련될 경우 보상 목적의 불필요한 치료는 줄어든 수 있음

- 경상환자의 치료비 100원의 가치는 향후치료비(합의금) 기준으로 123원으로 볼 수 있는데, 향후치료비 지급기준 마련은 보상목적의 치료 유인에 영향을 미칠 수 있음⁸⁾

6) 김진현·이인영·김준현·서동민·배현지(2017), 「제3자 행위로 인한 사고의 합의 후 건강보험 급여제한 실태와 정책대안」, 『보건경제와 정책연구』, 제23권 제4호, pp. 45~65

7) 전용식(2025. 5. 26.), 「자동차보험 상급병실 제도개선 전후 경상환자 입원진료비 비교와 시사점」, 『KIRI리포트』 보험연구원

8) 전용식(2025. 2. 24.), 「자동차보험 손해율에 투영된 제도개선 방안」, 『KIRI리포트』 보험연구원

〈표 3〉 2023년 자동차보험 상해급수별 치료비 대비 향후치료비 비율

(단위: %)

상해급수	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12~14
치료비 대비 향후치료비	39	36	43	42	51	64	72	55	61	76	81	123

주: 2023년 1월부터 2023년 10월까지 합의 기준임

자료: 국내 대형손해보험회사

○ 향후치료비 지급기준 마련과 더불어 경상환자 보상제도의 합리성 제고를 통해 자동차보험제도의 신뢰도를 높일 필요가 있음

- 휴업손해, 위자료 등 보상 기준의 합리화를 모색하고 자동차보험 보상 절차의 투명성을 제고하는 방안을 모색해야 함